（一）左心衰（必须关注肺）

①咳嗽咳痰，**双肺湿啰音**　肺V内压力传给支气管静脉(壁薄)

②咯血：痰中带血与肺毛细血管有关；大咯血与**支气管静脉**破裂（左心房压力突然增高）有关

VS 肺结核、支扩大咯血:支气管动脉

③不同程度的呼吸困难：严重支气管哮喘也可出现端坐呼吸

劳力性呼吸困难（最早，无特异性）	中老年活动后心悸气短
左心衰相对有特点的是 NYHA分级:III级 **夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸**	仰卧时回心血量增加致肺血量增加、仰卧时膈肌抬高致肺活量减少、夜晚迷走神经张力高致支气管收缩、熟睡时呼吸中枢敏感性下降
急性肺水肿/心源性哮喘	咳粉红色泡沫痰等

e.g 心肌收缩力↓→弱,异长调节代偿心肌收缩力↑→强→肌浆网放出钙↑,一部分放出的钙来不及被肌浆网完全回收→下一次可放出去的钙↓→钙瞬变幅度↓收缩力↓射血↓

门框变大　心衰患者的搏出量偏低,通过提高心率储备维持心输出量

相对性二闭

④心尖多向**左下**移位，**心尖收缩期**杂音，S_1↓，☆奔马律，交替脉 收缩力强弱交替

⑤混合性发绀（《诊断学》10 版教材 P20）：心脏泵血减少致周围组织灌注不足（周围性）、肺淤血使肺换气障碍（中心性）《内科学》10 版教材 P179 左心衰属中央型发绀

左心衰:湿肺咯血端坐移,交替发绀奔马音

心尖向左下移位　心音、附加心音、杂音

有急性靶器官损害　1-3周前驱感染、胸痛、左心功能不全、可有心肌坏死标志物↑

急性左心衰的可能可能最可能：高血压急症、急性心梗、急性心肌炎、急性瓣膜关闭不全等病史，突发呼吸困难、端坐呼吸、双肺湿啰音、咳粉红色泡沫痰

乳头肌断裂 → 急性二闭、急性主闭

腱索断裂

感染性心内膜炎

心源性哮喘 VS 严重支气管哮喘

共性：端坐呼吸

区别：

①支气管哮喘：呼气性呼吸困难，多为干啰音、可有沉默肺，X 线多无异常或双肺透亮度增加

②心源性哮喘：混合性呼吸困难，咳粉红色泡沫痰、多为湿啰音或干湿啰音共存，X 线多有左心扩大、肺门蝴蝶征（两只蝴蝶：急性左心衰、肺泡蛋白沉着症）牛奶洒了一地、吸引蝴蝶

肺气肿、膈肌下移(肺心病代偿期)、肝脏淤血(失代偿期右心衰)都会导致肝界下移,二者鉴别看肝痛不痛

鉴别肝源性、心源性水肿:颈静脉怒张、肝颈静脉回流征

（二）右心衰

①劳力性呼吸困难（缺氧）。左心衰发展到右心衰后患者呼吸困难等肺淤血症状反而会减轻 右心射血能力↓往肺循环射血↓

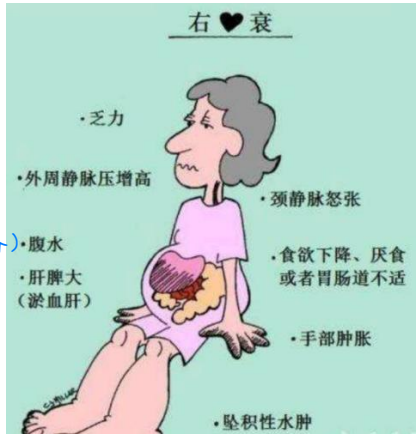
②消化道症状、颈静脉怒张、**肝颈静脉回流征（诊断右心衰最有价值）**、肝大伴压痛、**双下肢水肿（从身体低垂部位开始出现对称性凹陷性水肿）**、胸腹水（漏出液）我的心肝肾快吃药

肝淤血肿大→牵拉肝包膜(神经)

③心尖多向**左**移位，胸骨左缘 4-5 肋间收缩期杂音，奔马律，**奇脉/吸停脉** 严重的C.魔小说包邮

双侧肢体不对称的肿痛要考虑深静脉形成血栓





VS黏液性水肿(非凹陷性水肿):甲减(胫前)、少数甲亢(局限胫前)

学成诊断学:颈静脉怒张

- 右心衰:COPD/肺栓塞→肺心病
  - 扩心病、瓣膜病从左发展到右
  - 右室梗死
- 心包积液、缩心炎、限心病
- 气胸、肺癌
- ……